

إسم المريض رابعياً : ايمان هاشم عامر الشنشوري

المحافظة : القليوبية

الحي / المدينة : العبور

العنوان : العبور

رقم البطاقة : 26712090104886 رقم التليفون : 01110278341

تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 09-12-1967 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي خط علاج كيمائي ثانى للورم المنتشر طبقا للبروتوكول (Taxanes + Cyclophosphamide) [14221]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

التوقيع: 

التوقيع: (مكتبة)

التوقيع: (مستند رقم ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠)

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ايمان هاشم عامر الشنشوري National ID: 26712090104886	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالبدن و تحتاج الى Chemotherapy per Taxanes + Cyclophosphamide protocol

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

DMS
مفكرة العمل
٢٠٢٢

٢٠٢٢/٠٤
٢٩٧١٢٠٩٠١٠٤٨٦
مفكرة شركة شركة الحرمين
للصناعة التحويلية
التي
هاتى حضانة محمد حضان
الطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٤/١٧

١١

KN0713897

جمهورية مصر العربية
مملكة البحرين
إيمان
هاتم عامر الشنورى
١٦ يوليو ٢٠٠٤ حتى الخامس
العشر - القويبة

٢٩٧١٢٠٩٠١٠٤٨٦



Total DiP (mGy.cm):

Patient Name: Eman Hashem Amer ALSHSNHORI	Date: 31/12/2023
Exam: C.T.CHEST	Age: 56 Year(s)
Medical ID: 4887/2023	Pat ID: 45708

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Reported case of breast cancer:

I Chest:-

- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Small hiatus hernia.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with beaver tail configuration. No focal lesions or contour irregularities. It shows heterogenous texture mostly representing focal fatty infiltration.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Right renal pelvis hypodense lesion ?cyst measuring 3.5 X 1.7 cm.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.

Name: إيمان هاشم عامر الشنشوري		
MR. : 7317		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient underwent right breast surgery with sentinel lymph node biopsy and axillary lymph node dissection (RT SM+ALND) for ductal carcinoma in situ with microinvasion (PT1MIC NO) in April 2024. Pathology reported 0/14 lymph nodes involved, clear margins, immunohistochemistry showing estrogen receptor 0/8, progesterone receptor 5/8, HER2 0, and Ki-67 15%. The patient was placed on surveillance until the most recent mammogram on 29 March 2026, which identified a BIRADS 4c suspicious lesion in the left breast. Biopsy of this lesion revealed invasive ductal carcinoma, grade 2, with ER 8/8, PR 8/8, HER2 0, and Ki-67 15%. In the most recent primary-care note dated 23 May 2026, the patient is described as a 58-year-old male with a history of right-sided mastectomy and left-sided abscess drainage in 2025. He has now developed a new left-sided invasive ductal carcinoma classified as luminal A, clinically staged as T2 with no evidence of metastasis (NO MX). The case is pending further staging and multidisciplinary team discussion.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
Lt breast BIRADS 4c suspicious lesion Bx showed IDC G2 ER 8/8 PR 8/8 HER2 0 KI67 15%		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Eman Hashem Amer ALSHSNHORI	Date: 31/12/2023
Exam: C.T CHEST	Age: 56 Year(s)
Medical ID: 4887/2023	Pat. ID: 45708

- No abdominal or pelvic masses or collections.
- 1st degree degenerative L4 spondylolisthesis.

Opinion:

- Reported case of breast cancer.
- No pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.
- Right renal pelvis hypodense lesion ?cyst for further assessment.

Dr. Mohammed Mohsen, MSc

Signature Prof. Mohamed Gomaa
31/12/2023 07:10 م

Dr. M. Gomaa, M.D.



Patient Name : الأستاذة / أماني هاشم علي الششتوي	Request No. : 13000295
Patient No. : 26712090104886	Request Date : 18/01/2024
Path No. : 270/24	Verification Date : 03/02/2024
Sex : Female	Financial Category : أورام داء السلالم - تنقة الدولة
Age : 56 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass, in patient with history of DCIS.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 18/01/2024, 10:30 am.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores, up to 1 cm long, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Ductal carcinoma in situ (DCIS).
- * Intermediate grade.
- * No invasive element in specimen received.
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Negative nuclear reaction in the tumor cells (Allred score 0/8).

Diagnosis:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

Ductal Carcinoma In Situ (DCIS), Intermediate Grade, no invasive component in material received.

IPT:

- ER: Negative (score 0/8).

• Scoring system: "ER,"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 06/02/2024 10:47:10

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mizr El Qalema - Cairo, Egypt

**FULL FIELD DIGITAL SPECTRAL MAMMOGRAPHIC EXAMINATION
OF BOTH BREASTS WITH CONTRAST:**

CLINICAL SUMMARY: Right pathology proved Breast CA

IMPRESSION:

LEFT BREAST: (BIRADS 3= Probably Benign) prominent ducts and scattered cysts.

RIGHT BREAST: (BIRADS 6 = Pathology proved malignant) Central non mass uptake as described.

TECHNIQUE:

Craniocaudal & mediolateral oblique; low energy & recombined (contrast enhanced) views.

High Resolution Ultrasound with Elastography & Color Doppler.

FINDINGS:

Breast Density : ACR D : Dense fibroglandular pattern.

Background Uptake: Marked

LEFT BREAST:

- Low energy (non contrast images) show: No mass lesions, spiculations or suspicious microcalcifications detected. Benign calcifications are visible.
- Recombined (post contrast images) show: no sign of pathological enhancement. However there is marked background uptake.
- Complementary US demonstrated no solid lesions, prominent retroareolar ducts and scattered 5mm cysts are seen.
- Normal skin/nipple/areolar complex. Preserved axillary LNs.

RIGHT BREAST:

- Low energy (non contrast images) show: an asymmetry with distortion at the central region.
- Recombined (post contrast images) show: intense nodular heterogenous contrast uptake measuring 5x6x 3.5cm in diameter. It starts 1.5cm from the nipple and extends from 9:00 to 3:00.
- Complementary US demonstrated a large underlying distortion with nodular texture at the above site with scattered vascularity.
- Normal skin/nipple/areolar complex. Preserved axillary LNs.

Thanks for your Reference,
Dr. Norran Hussein, MD FRCR



أحمد
9-c9



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية



09/29/2026

□

MDT FORM

Name: أحمد هشام أمير //	MRN: 7317
Age: 59 Y	ID: 26712090104886
Menopausal Stz	Phone: * 0111278341
NRS SCORE:	Marital Status:
BMI:	Family History: +ve fh
Gender	Reason Of MDT:
CO Morbidity: m.free	post op
Surgical History: * rt sm & slnb 2024	ECOG Performance Status ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Clinical Data:

R

L

BX:

ER: **8/8** PR: **8/8** HER2: **0** KI67: **15**

History:

Sonomammography:

sp lt sm& slnb upfront
ldc g2

dcis

nipple& areola >> free
resection margins >. free deep margin

slnb 0/5

Biomarker/Molecular

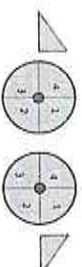
Metis Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

Portacath insetion
Adj Docetaxel - Endoxan X 6 cycles (assess neuropathy before starting)
Femara x 7 years + Zometa / 6 m

T N M



Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د خالد عبدالعزیز	د محمد نور ثوري		

Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناتيونال - مصر - مصر عسل الدولية لوجي

Patient Name	ابن هاشم علي	Case No.	359166
Sex/Age	Female 58 Y	Patient No.	26114
Registered Date	19/8/2026 02:00:21 PM	Referred By Dr.	
Validation Date	26/9/2026 12:12:43 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	28/9/2026 12:04:00 PM	Pathology No.	2658/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer (up-front).

Nature of the specimen: Left simple mastectomy & Sentinel lymph nodes biopsy.

Gross Examination:

- * Left simple mastectomy specimen measured 22x17x10 cm, with covering skin ellipse measured 20x15 cm. Nipple & areola looked unremarkable grossly.
- * Serialing showed single firm mass measured 4.0x2.5x2.5 cm, with surrounding grey, white area measured about 6.0x4.0x4.0 located 0.1 cm from the deep surgical margin.
- * Sentinel lymph nodes: Fibrofatty tissue piece measured 3.0x3.0 cm, entangling 3 lymph nodes, the largest one measured 3.0x1.0x0.5 cm.

* Block designation "12 Blocks":

1- G/W area, 2:5- Mass, 6:9- G/W area, 10 - Deep margin, 11- Nipple & areola, 12- SLNs.

- Gross was done by: Dr. Aya Ezzat.

** Frozen (Intra-operative) results:

- SLNs: Three free sentinel lymph nodes (0/3) (Sinus histiocytosis).

Frozen sections examined by: Prof. Dr. Maha Guinei.

Microscopic examination:

- **Histological type:** Invasive duct carcinoma.
- **Tumor size:** 4.0x2.5 cm.
- **Grade:** 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 1).
- **Ductal carcinoma in situ:** 80% Extensive component, low & intermediate grades DCIS (Solid& Cribriform patterns with comedo type necrosis).
- **Microcalcification:** Present.
- **Perineural invasion:** Absent.
- **Angioinvasion:** Absent.
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Mild.
- **Nipple & areola:** Free.
- **Resection Margins:** Free deep surgical margin.
- **Sentinel lymph node involvement:** Five nodes free of viable metastatic deposits (0/5).

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة 6 - مصر
Room No. (4) - First Floor- Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	ايمن هشام علم	Case No.	359166
Sex/Age	Female 58 Y	Patient No.	26114
Registered Date	19/8/2026 02:00:21 PM	Referred By Dr.	Surgery
Validation Date	26/9/2026 12:12:43 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	28/9/2026 12:04:00 PM	Pathology No.	2658/26

Diagnosis:

Left breast, (up-front), simple mastectomy & Sentinel lymph nodes biopsy:

- Invasive duct carcinoma, grade 2.
- 80% Extensive low & intermediate grades ductal carcinoma in situ (Solid& Cribriform patterns with comedo type necrosis).
- Sentinel lymph nodes: Five sentinel lymph nodes free of viable metastatic deposits (0/5).
- Nipple & areola: Free.
- Surgical margins: Free deep margin.
- Stage: pT2, pN0.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.



خريطة رقم (4) - الطور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Alser El Qadema - Cairo, Egypt